内科含诊断 COPD ★★★（0~3 题）

表现

- 肺功能（首选和最佳，2016）
  - 特征和诊断标准：持续气流受限（吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC < 70\%$，2021、2022、2025）
  - $FEV_1\%$ 预计值评估严重程度：≥ 80%、≥ 50%、≥ 30%、< 30%（2012、2020）
- 中老年、长期咳痰喘、吸烟
  - 呼气性呼吸困难
  - 肺气肿体征（2010、2024）
    - 桶状胸：X 线双肺透亮度增加
    - 语音震颤↓、过清音、呼吸音↓、呼气音延长、湿啰音或干湿啰音共存
    - Kronig 峡增宽、心浊音界缩小、肺下界和肝浊音界下移

可能可能最可能（2016、2020）

治疗

稳定期

①低风险 + 症状少（A 组）：一种支气管扩张剂（2019、2020）
如 SABA（沙丁胺醇 / 特布他林）、SAMA（异丙托溴铵）、
LABA（沙美特罗 / 福莫特罗）、LAMA（噻托溴铵）、茶碱类药
②低风险 + 症状多（B 组）：LABA+LAMA
③ E 组（高风险）：LABA+LAMA 或 LABA+LAMA+ICS（血嗜酸性粒细胞≥ 300，ICS 如布地奈德 / 氟替卡松 / 倍氯米松“不服呗”，2013）
低风险：去年中度急性加重≤ 1 次；高风险：去年中度急性加重≥ 2 次或住院
症状少：剧烈、快步、爬坡时呼吸困难；症状多：需停下来休息或几乎动不了

必要时祛痰药（乙酰半胱氨酸）

长期家庭氧疗改善预后：$PaO_2 \geq 60$、$SaO_2 \geq 90\%$

急性加重期

- 若因感染加重（2023）：抗生素
- 支气管扩张剂（2016）
- 需要住院治疗者可口服或静注糖皮质激素（泼尼松 / 氢化可的松 / 甲泼尼龙），必要时祛痰药
- 低流量吸氧（2008）：氧流量 1~2L/ 分（氧浓度约 30%）

其他

- 禁用吗啡
- 意识障碍（肺性脑病）AECOPD III级
  - 检查：血气分析
  - 治疗：有创机械通气（气管插管或切开，2023）；禁用地西泮等镇静药
- 多不补碱，pH < 7.2 可补碱（2008、2013）